

시험 관련 코멘트



소화불량/만성 복통의 경우 복통과 함께 나타나거나 단독 증상으로 흔히 발생할 수 있습니다. 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인을 감별하는 것이 중요하

며, 병력 청취와 신체 진찰에서 감별 진단을 시행할 수 있어야 합니다. 소화불량의 기질적 원인으로는 신생물, 소화성 궤양/역류 질환, 위, 간담체의 염증/허혈, 위장자 운동 이상 등을 고려해야 합니다.

병력 청취 시 증상이 **위와 관련된 경우 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력**을 물어보는 것이 좋습니다. 평소 식습관이 소화불량과 밀접한 관련이 있으므로 사회력에서 물어보아야 합니다. 악화/완화 요인에서 원인 질환에 따른 위험 요인 외에도 공복 시/식후 소화불량이 심해지는지를 물어본다면 진단 범위를 좁혀 갈 수 있습니다. 소화불량의 경우 **과거 소화기 병력을 확인**하는 것이 중요합니다. 그동안 건강 검진에서 상부 위장관내시경, 대장내시경을 받은 적이 있는지, 이상 소견은 없었는지 역시 확인해야 합니다. 원인 질환을 감별하기 어렵다면 기본으로 **기능성 소화불량 가능성을 염두**하는 것이 좋습니다.

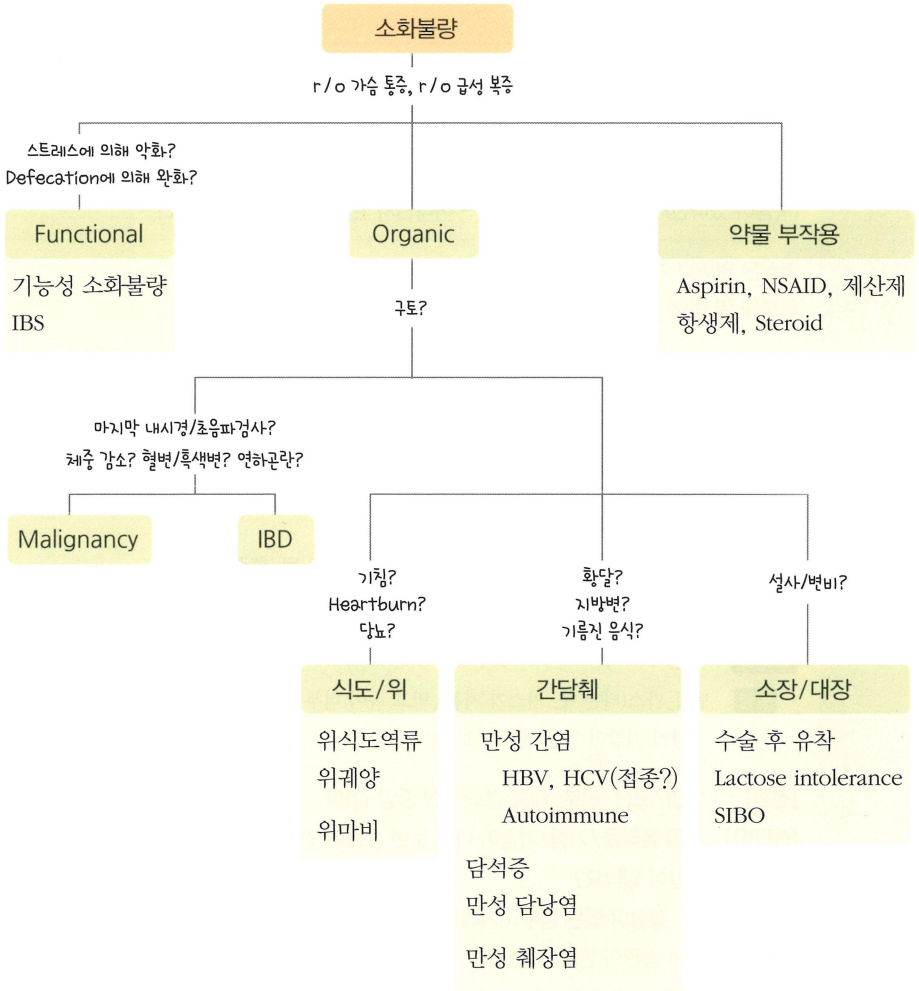
신체 진찰의 경우 소화불량 항목은 황달과 탈수를 확인하고, 림프절을 촉진하고, 복부 진찰(필요 시 Murphy's sign도) 진행해야 합니다.

환자 교육에서 **금주, 금연 뿐만 아니라** 카페인인 경우 위산 분비를 촉진하고 식도조임근을 이완시키기 때문에 **커피를 줄이는 것**에 대한 교육도 필요합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
위 / 소장	미란 / 궤양	위식도역류병 (GERD)	[병력] 명치 부위에 타는 듯한 통증, 식후/누울 때 악화, 제산제 복용 시 완화 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 pH검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
		위염★ / 위궤양★ / 십이지장궤양★	[병력] 속쓰림, 식후에 악화(위궤양), 공복 시 악화(십이지장궤양), 명치부 통증 [검진] 상복부 압통 있을 수 있음	[검사] 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, <i>H. pylori</i> 제균 치료

위 / 소장	종양	위암★ (gastric cancer)	[병력] 체중 감소, 소화불량, 흑색변, 이전 위내시경에서 궤양 소견 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경점막절제술, 항암 치료
	마비	당뇨병 위마비 (diabetic gastroparesis)	[병력] 오래된 당뇨 병력/ 복부 팽만감/음식 구토/ 상복부 불편감/식후 속쓰림 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 위배출검사 [치료] 당뇨 조절, Metoclopramide, Cisapride
간 담 체계	담	담석증★ (cholelithiasis) 만성 담낭염★ (chronic chole cystitis)	[병력] 담석 진단, RUQ 통증, 오심, 구토 [검진] RUQ 압통 있을 수	[검사] 상복부초음파, LFT [치료] 쓸개절제술
	췌	만성 췌장염 (chronic pancreatitis)	[병력] 심와부 통증, 제산제 복용 후에도 완화 안 됨, 음주 후 악화, 지방변 [검진] 심와부 통증, 등으로 뻐치는 통증	[검사] 복부초음파, 복부 CT, 복부 MRI, 내시경역행담관조영 [치료] 췌장효소 보충, 금주/금연, 식이 조절(과식, 고지방식 자제), 통증 조절
	간	만성 간염 (chronic hepatitis)	[병력] 피로, 식욕 저하, 구역, 구토, 근육통, 소변색 진해진, 황달 [검진] 간비대될 수 있으나 확인은 어렵다.	[검사] HBsAg, anti-HAV, anti-HCV, LFT [치료] 항바이러스제, 보존적 치료
기타		젖당불내성★ (lactose intolerance)	[병력] 우유 마시면 속이 불편함, 묽은변 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 수소날숨검사, 젖당부하검사 [치료] 유당회피요법
		과민대장증후군★ (IBS)	[병력] 젊은 여성/만성적 복통/ 배변 후 완화/배변 습관 및 양상 변화/복부 팽만/잦은 트림 및 방귀/소화불량/ 스트레스 시 악화 [검진] 경미한 복통	[검사] 대변검사, 대장내시경, CBC [치료] 심리적 안정, 적당한 운동과 휴식, 식습관 교정(고섬유, low FODMAP, 술/커피 줄이기), 진경제, 완하제
		기능 소화불량★ (functional dyspepsia)	[병력] 상복부 통증/쓰림, 식후 충만감, 조기 포만감, 불규칙한 식습관 및 생활 습관/ 스트레스/내시경 정상 [검진] 대체로 정상, 상복부 압통	[검사] 원칙적으로 필요 없으나 위내시경, 신속요소분해효소검사 등으로 다른 질환 감별 [치료] 양성자펌프억제제(궤양형), 운동 촉진 약물(운동장애형)



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 속이 쓰렸나요? → 소화가 안됐나요? 갑자기 그러신 건가요?/아니면 서서히 속쓰림이 나타났나요? 하루 중 언제 주로 그런 것 같으세요?
L	(복통이 있다면) 위치는 어디인가요? → 어디인지 짚어주실 수 있으신가요?
D	증상은 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 비슷한 증상이 있으셨나요? 당시 치료는 받으셨나요?
C	[양상] 속이 어떻게 불편하신가요? (타는 듯/속이 더부룩/가스 차는 느낌/소화가 안 됨/통증) [정도] 증상이 얼마나 심하신가요? (일상 생활에 지장을 받으시나요?/NRS) 암기법 탄 돈가스 먹고 속이 더부룩해져서 일지에 쓰기로 하였다. 설명 탄 돈가스(타는 듯, 가스가 차는) 먹고 속이 더부룩해져서(속이 더부룩한) 일지(일상 생활에 지장이 있는)에 쓰기로 하였다.
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 감소(악성 종양 감별) [GERD] 신물 올라옴/기침/가슴이 타는 듯한 통증이 있나요? [간담체] 황달이 있나요? + 황달이 있는 경우 : 가려움, 복수, 소변색/대변색 변화 [IBS] 배변 습관의 변화가 있나요? [소화기] 식욕 저하/구역/구토/설사/변비/혈변/흑색변/복통/속쓰림/복부 팽만/삼킬 때 어려움(연하곤란)이 있나요? 암기법 연신 물배만 채우는 습관은 곤란하다. 설명 연신 물(신물이 올라옴)배만 채우는 습관(배변 습관의 변화)은 곤란하다(연하곤란). [정신] 우울, 불안

F	[악화/완화 인자] open question
	[위염/위궤양] 식사하기 전과 후 중에 더 속쓰림이 심해지는 상황이 있나요?
	[젓당불내성] 우유나 기름진 음식을 먹으면 더 속이 쓰린가요?
	[IBS] 대변을 보고 나면 속쓰림이 완화되나요?
	[스트레스] 최근에 스트레스를 받는 일이 있었나요?
	암기법 제우스(우유, 스트레스)는 음식 대기 중
	설명 제우스(우유, 스트레스)는 음식(식사) 대기(대변 본 후, 기름진 음식) 중
E	이전에 건강 검진 받은 적 있으세요?/위내시경, 대장내시경 받으셨나요?/결과는 어땠나요? 간염 예방접종은 다 맞으셨나요? ☞ 위/대장내시경 시행 여부와 결과도 반드시 문도록 합니다.
외	수술을 받으신 적 있나요?/배를 다치신 적 있나요?
과	고혈압/당뇨/고지혈증/간질환 있으신가요? 위염이나 위궤양을 진단 받은 적 있으신가요?
약	복용 중인 약물이 있나요? (아스피린, NSAID, 제산제, 항생제, 스테로이드) ☞ 시간이 없을 경우 진통제(NSAID)와 항생제 복용 여부를 묻습니다.
사	직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요? 음주는 하세요?/흡연은 하시나요?/커피는 하루에 몇 잔 정도 드시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/맵거나 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중에 위암이나 위궤양 등을 진단받은 분이 있으신가요?
여	실례지만 마지막 월경 시작일이 언제인가요?/월경 주기?/월경통/월경량 심한 편? 임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 혈색 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입인두 : 위산 역류 3. 목★ : 림프절 촉진(supraclavicular lymph node까지 촉진) 4. CVAT : (복통 호소 시 시행을 고려합니다.) 뒤로 돌아주세요. 반드시 양쪽 다 확인, 양쪽을 한번씩만 치는 것이 아니라 연속적으로 위에서 내려가며 여러 번 쳐준다.

[누워서] 5. 복부★

신진 수술 흔적, 팽만/청진 5구역, 3초간/타진 4군데 이상/촉진 알, 깊 촉진

⊕ 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진 및 촉진

[특이검사★] Murphy's sign

6. DRE : 직장수지검사

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	소화불량 or 속쓰림 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 위궤양이 가장 의심됩니다. [병력 상 당뇨가 오래 조절되지 않은 경우] 당뇨병 위마비 등으로 당뇨가 소화불량 원인일 수 있습니다. 이 경우 혈당을 엄격하게 조절하는 것이 중요합니다.
감별 진단	그러나 최근 체중이 감소하고 식욕 변화도 있으면서 평소 음주와 흡연력도 있으셔서 위암의 가능성을 배제할 수는 없습니다.
검사	이런 경우 위내시경검사로 위에 어떤 기질적 문제가 있는지 확인하는 것이 필요합니다. 검사를 진행해도 괜찮을까요? 검사를 위해 지금부터 금식을 하셔야 합니다.
치료	만약 위궤양으로 진단되면 위산 분비를 억제하는 약을 드리고 제균 치료를 시행해 볼 수 있습니다. 만일 위암으로 진단되면 수술이나 항암 치료 등이 필요할 수 있습니다. 가능성 소화불량으로 진단 시 생활 습관을 개선하고 소화불량을 일으키는 약물을 중단하고, 추가로 위산억제제나 위장운동촉진제 약물 치료를 병행할 수 있습니다.
예후	하지만 아직 검사를 진행한 것이 아니기 때문에 너무 걱정하지는 마세요. 이렇게 증상이 빨리 나타났을 때 병원에 오신 것은 정말 잘하신 것입니다.
교육	[응급] 지금은 증상이 심하지 않지만 집에 가서서 음식을 삼키기 힘들거나, 어지럽고, 피를 토하거나 변에 피가 묻어나오거나 검은 변을 보면 즉시 병원을 방문해 주세요. [식습관] 생활 속에서 맵거나 자극적인 음식을 피해주시고, [생활 습관] 적절히 운동을 해주면서 스트레스를 덜 받게 하는 것 또한 중요합니다. 금연과 금주가 중요하며, 카페인의 경우 위산 분비를 촉진시키니 섭취를 줄여준다면 증상 완화에 더 도움이 됩니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획★

- ① 복부 X-ray, 복부 CT
- ② 위식도내시경
 - 45세 이상
 - 악성 경고 증상 +
 - 만성 증상에 변화 +
 - 환자가 악성 종양에 대해 걱정할 때
- ③ 궤양 : 요소달숨검사, 신속요소분해효소검사(위내시경 시 같이 시행)
- ④ GERD : 24시간 식도 pH검사

❖ 치료 계획

위장관	위식도역류	양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
	위궤양	양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제
	십이지장궤양	양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제
	위암	위절제술, 내시경적 점막하절제술, 항암 치료
간담체	담석증/만성 담낭염	금식 유지, 항생제, 수액
	만성 췌장염	금식 유지, 췌장효소 보충, 혈당 조절
	간염	항바이러스제, 보존적 치료
기타	기능성 소화불량	심리적 안정, 적절한 운동과 휴식
	과민대장증후군	심리적 안정
	당뇨성 마비	당뇨 조절
	젖당불내성	유당 회피

❖ 환자 안내 / 생활 습관 교육

- ① 생활 습관 개선의 중요성 : 술/담배 제한, 적절한 유산소 운동, 체중 조절, 식습관 개선(규칙적 식습관, 지방이 적고 섬유소가 많은 음식), 스트레스 관리, 카페인 제한

- ② 당뇨병이 조절되지 않고 있는 경우 당뇨가 소화불량의 원인일 수 있음을 설명하고 엄격한 조절 강조
- ③ 기질적 문제가 의심되는 경우 복부 CT 등 추가적인 검사가 필요할 수 있음을 강조



keyword

소화불량/만성 복통의 경우 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인으로 나누어
감별하기

소화불량의 위치를 확인해 기질적 원인인 경우 감별하기

기질적 원인의 위험 요인 파악 : 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력, 스트레스, 음주/흡연

교육 : 생활 습관 개선(식습관+운동), 스트레스 조절, 금주/금연/카페인 섭취도 줄일 것을 교육하기

응급 상황 교육 : 연하곤란, 어지럼, 토혈, 혈변/흑색변 시 내원 교육



Memo

